科普资料汇编

精神分裂症资料库

模块内容与延伸专题

> **阅读提示：**本资料仅供学习科普，不能替代精神科专业评估、诊断或处方。请勿据此自行判断病情或增减、停用药物；遇到迫切安全风险，请联系当地急救或急诊服务。

目录

资料库总目录

目录

模块1：基础定义与疾病概况

1. 疾病正式名称

2. 疾病本质

3. 发病流行病学

4. 疾病分型演变

5. 常见名词释义

模块2：病因与发病机制

1. 遗传因素

2. 大脑生物学机制

3. 环境诱因

4. 心理社会因素

5. 目前研究局限

模块3：临床表现

3.1 阳性症状

3.2 阴性症状

3.3 认知损害

3.4 情绪相关表现

3.5 疾病分期

模块4：诊断与鉴别诊断

1. 诊断标准

2. 诊断流程

3. 鉴别诊断

4. 评估量表简介

模块5：治疗方案

5.1 药物治疗

5.2 心理社会干预

模块6：预后、复发风险与康复管理

1. 影响预后的因素

2. 复发预警信号

3. 长期康复管理

4. 社会功能康复

5. 风险内容

模块7：社会议题、误区与污名

1. 常见谣言澄清

2. 家属照护难点

3. 法律与权益

4. 大众科普方向

模块8：参考文献、资源与研究进展

1. 权威来源标注

2. 区分证据等级

3. 延伸阅读与求助资源

4. 资料库备注栏

可选附加小模块

共病专题

患者康复视角

照护手册

精神分裂症资料库（自建整理方案）

> 重要前置提醒：**本资料库仅作科普、知识学习用途，绝对不能替代临床诊断、用药方案、面诊治疗；严禁用于自行判断病情、调整药物。所有内容标注信息来源，区分【临床共识/研究结论/个人经验/争议观点】。**

整体建议分成**8大模块**，下面列出每个模块可以收集整理的具体内容，你可以按需删减。

模块1：基础定义与疾病概况

核心：是什么病，基本概念，容易混淆的名词

1. 疾病正式名称（精神分裂症，ICD-11、DSM-5诊断名称）
2. 疾病本质：大脑神经发育/神经递质相关的慢性重性精神障碍；**不是人格分裂**（重点澄清大众误区）
3. 发病流行病学：发病高峰年龄、男女差异、患病率、复发率、致残特点
4. 疾病分型演变：旧的分型（偏执型、青春型、紧张型等），DSM-5/ICD11不再强调传统亚型的说明
5. 常见名词释义：阳性症状、阴性症状、认知症状、前驱期、发作期、缓解期、残留状态

模块2：病因与发病机制（多因素，无单一病因）

1. 遗传因素：家族风险、同卵双生子研究，**不是“父母有就一定会遗传”**
2. 大脑生物学机制：多巴胺假说、谷氨酸假说；脑结构（海马、前额叶）影像学发现
3. 环境诱因：孕期风险（感染、缺氧）、童年创伤、长期高压、物质滥用（大麻是明确高危）、重大应激事件
4. 心理社会因素：只作为诱因，**不是“想不开、性格差导致”**（纠正常见污名化误区）
5. 目前研究局限：病因没有完全破译，各种假说的证据强弱区分

模块3：临床表现（症状系统，重点区分阳性/阴性/认知）

3.1 阳性症状（“多出”的体验）

幻觉（幻听最常见，幻视、幻嗅等）、妄想（被害、关系、夸大、钟情妄想等）、思维破裂、行为紊乱、紧张症

3.2 阴性症状（“失去”能力）

情感淡漠、意志减退、社交退缩、言语贫乏、快感缺失

3.3 认知损害（很多患者长期核心困扰）

注意力差、工作记忆下降、执行功能受损、决策困难，很多时候阴性+认知症状更影响长期生活

3.4 情绪相关表现

抑郁、焦虑、易激惹；区分是疾病本身，还是药物副作用、心理应激

3.5 疾病分期

- 前驱期（发病前，微妙变化，很难识别）
- 急性发作期（明显精神病性症状）
- 巩固期（症状控制，防复发）
- 维持期（长期稳定康复）

模块4：诊断与鉴别诊断

> 注意：**诊断权仅限精神科执业医师**，资料库写明：不能自测诊断

1. ICD-11、DSM-5 两套诊断标准原文摘要
2. 诊断流程：病史采集、精神检查、躯体检查、抽血/影像（排除器质性问题）
3. 鉴别诊断（非常重要，很多情况会被误判）

- 双相情感障碍伴精神病性症状
- 重度抑郁伴精神病性症状
- 脑器质性疾病：脑炎、脑肿瘤、脑梗、脑外伤
- 物质所致精神病（毒品、部分药物诱发）
- 解离障碍、妄想性障碍、自闭症等

1. 评估量表简介：PANSS阳性阴性量表、SAPS/SANS，说明量表**仅辅助评估，不等于诊断**

模块5：治疗方案（循证医学为主）

5.1 药物治疗（一线核心）

- 抗精神病药分类：第一代（传统）、第二代（非典型，现在首选）
- 常见药物清单，各自特点、常见不良反应（体重增加、泌乳素升高、锥体外系反应、嗜睡等）
- 长效针剂：适用场景、优势（解决漏服，降低复发）
- 重要内容：减药、停药原则；**严禁自行突然停药**，撤药反应、复发风险
- 辅助用药：合并抗焦虑、抗抑郁、情绪稳定剂的适用情况
- 特殊治疗：MECT（无抽搐电休克）：适应症、流程、疗效、常见顾虑与不良反应

5.2 心理社会干预（药物之外康复核心）

认知行为治疗CBTp、家庭干预、社交技能训练、职业康复、支持性心理治疗

> 说明：单纯心理咨询**不能治愈**急性精神病发作，仅作为药物基础上的辅助康复手段

模块6：预后、复发风险与康复管理

1. 影响预后的因素：起病年龄、前驱期长短、是否尽早规范治疗、家庭支持、坚持服药、认知损害程度
2. 复发预警信号（重点实用内容）：睡眠变差、多疑加重、社交退缩、情绪反常、旧症状复现
3. 长期康复管理：复诊规律、药物依从性、作息、戒酒戒毒品、压力管理
4. 社会功能康复：居家生活、社交、就业、学习的支持方案
5. 风险内容：自伤、伤人风险评估，危机处理原则

模块7：社会议题、误区与污名

1. 常见谣言澄清：

- 不是“疯子”，不是暴力犯罪者（患者暴力风险并不高于普通人群，急性发作期才存在风险）
- 不是“被鬼神附身”、不是单纯心理问题
- 不等于终身完全丧失劳动能力；部分人可以维持稳定生活、工作

1. 家属照护难点：家属心理压力、沟通技巧、如何避免对立
2. 法律与权益：精神障碍患者的民事、监护，残疾证申请，医保政策，就业保护、隐私保护
3. 大众科普方向：如何减少歧视

模块8：参考文献、资源与研究进展

1. 权威来源标注：《中国精神分裂症防治指南》最新版、ICD/DSM原文、权威医学期刊、国内精神医学学会资料
2. 区分证据等级：指南推荐（强证据）、前沿研究（初步证据）、假说（待验证）
3. 延伸阅读、正规公益求助渠道、专业机构
4. 资料库备注栏：所有未定论研究要标明“尚在研究，未用于常规临床”

可选附加小模块（看你需求）

- 【患者康复视角】：康复者自述（注明是个人体验，不能代表全部患者）
- 【照护手册】：家属实操沟通、危机应急清单
- 【共病专题】：精神分裂症常共病抑郁、焦虑、物质依赖、代谢综合征（药物带来高血脂高血糖）

资料库建设的2个关键规则（强烈建议写在资料库首页）

1. 免责声明：**资料库为知识整理，不能作为诊断、用药依据；任何症状务必前往正规精神卫生中心/医院精神科就诊。**
2. 来源标注原则：每一条关键结论尽量标注来源，区分临床指南、综述、个案、科普文章，避免混杂网络传言。

1. 疾病正式名称

> 本页用于说明疾病名称、分类系统中的名称与编码，以及容易混淆的叫法。名称和编码会随分类版本及各地实施情况变化，医疗记录应以就诊机构实际采用的诊断分类为准。

1.1 现行名称

- **中文名称：精神分裂症**
- **英文名称：Schizophrenia**
- **ICD-11：**精神分裂症归入“精神、行为或神经发育障碍”章节，类别代码为 **6A20**。具体诊断可附带发作次数、病程和症状等描述信息。
- **DSM-5：**诊断名称为 **Schizophrenia**；DSM-5-TR（2022）沿用该名称。DSM 是美国精神医学学会编制的诊断分类手册，主要用于临床和研究参考。

ICD 是世界卫生组织维护的国际疾病分类，广泛用于健康信息记录和统计；DSM 是另一套诊断分类。二者的条目、诊断要求和编码用途并不完全相同。各国家或地区也可能按本地政策分阶段采用 ICD 版本，因此不能仅凭某一国际编码推断当地病历、医保或行政事务具体使用的编码。

1.2 名称的历史

19 世纪末，德国精神科医生 Emil Kraepelin 使用 **Dementia praecox**（常译“早发性痴呆”）描述一组通常较早起病、病程可能迁延的精神障碍。这里的“痴呆”是当时的历史术语，不等同于今天所说的老年期神经认知障碍。

瑞士精神科医生 Eugen Bleuler 于 20 世纪初提出 **Schizophrenia** 一词，强调思维、情感、感知等心理功能之间可能出现的联系紊乱。词源中的“分裂”不是“一个人有多个身份”，也不表示患者具有多重人格。该词的历史含义与现代大众对“人格分裂”的误解并不相同。

“青春痴呆”等旧译或旧称只适合在历史语境中解释，不应作为当前诊断名称使用。

1.3 简称、俗称与不推荐称呼

- **“分裂症”**：偶见于非正式书面简称，不宜替代完整诊断名称。
- **“精神病”**：范围很广，可指多种精神障碍或精神病性状态，不是精神分裂症的同义词。
- **“疯子”** **“神经病”**：不是医学诊断名称，含有贬损或污名化意味，不建议使用。“神经病”在日常中文中含义混乱，也可能被理解为神经系统疾病。

1.4 容易混淆但并非同一诊断的名称

- **分裂样障碍（schizophreniform disorder）**：DSM 分类中的独立诊断，症状表现可与精神分裂症相似，但病程持续时间要求不同。它不是“轻型精神分裂症”的俗称，也不能只凭症状相似就判断两者关系。
- **分裂情感性障碍（schizoaffective disorder）**：精神病性症状与显著心境发作在病程中的关系，是鉴别诊断的重要部分；属于不同诊断。
- **解离性身份障碍（dissociative identity disorder）**：涉及身份状态和记忆等方面的解离性问题，和精神分裂症不是同一种疾病。“人格分裂”是其旧称或俗称之一，不应拿来称呼精神分裂症。
- **妄想障碍（delusional disorder）**：以妄想相关表现为核心的另一诊断；具体鉴别要结合整体症状、病程和功能变化。

诊断名称相近不代表疾病相同；诊断须由专业人员结合完整病史、症状和病程判断。

1.5 名称争议与使用原则

“精神分裂症”中的“分裂”容易使公众误以为是人格分裂，可能加深误解和污名。台湾地区常用“思觉失调症”这一名称；不同地区中文译名不同。撰写面向中国大陆读者的资料时，可用“精神分裂症”作为疾病名称，同时主动解释它**不等于解离性身份障碍或多重人格。**

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 疾病分类与编码
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- American Psychiatric Association：DSM-5

2. 疾病本质

2.1 什么是精神分裂症

精神分裂症是一种严重的精神障碍，主要影响一个人对现实的感知、思维组织、情绪表达和行为。它可能出现精神病性症状，也可能伴随认知、动机和社会功能方面的困难。症状组合、严重程度和病程因人而异，并非每位患者都会出现相同表现。

它不是“人格分裂”，也不是意志薄弱、道德问题或单纯“想不开”。确切病因尚未完全阐明，目前研究认为遗传易感性、脑发育与多种生物学过程、生活经历和环境等因素可能共同参与；不能把疾病归结为单一的神经递质失衡，也不能由某一种生活事件推断某人一定会患病。

2.2 常见症状领域

临床上常从多个方面理解症状。以下是便于科普的分类，不是自测清单：

1. **精神病性症状：**例如幻觉、妄想，以及思维或言语组织明显紊乱。幻听较常被报告，但不同人的体验不同。
2. **阴性症状：**相对于既往功能出现减少，例如主动性下降、言语减少、情感表达减少、社交兴趣下降。需要与抑郁、药物副作用、社会隔离和其他身体问题区分。
3. **认知困难：**注意、工作记忆、信息处理速度、计划和问题解决等方面可能受影响，程度也因人而异。
4. **情绪与睡眠问题：**抑郁、焦虑、易激惹或睡眠变化可能伴随出现，也可能与其他共病、药物或生活压力有关。

这些表现并非精神分裂症所独有；单个症状或网络量表结果不能确诊。

2.3 病程与恢复

精神分裂症通常需要持续的专业评估与支持，但“慢性”不等于症状必然持续不变或完全无法恢复。部分人经历一次或多次明显发作，之后症状减轻并恢复部分功能；另一些人需要长期治疗和不同程度的支持。早期识别、合适的治疗、身体健康管理、家庭与社区支持等可能帮助改善生活质量和功能。

这里的“恢复”可包括症状缓解、生活自理、学习工作和社会参与等多个方面，不一定意味着所有困难完全消失。每个人的目标和进程应个别化制定。

2.4 与“人格分裂”的区别

精神分裂症中的“分裂”是疾病名称的历史译法，**不是人格分裂成多个身份**。解离性身份障碍属于解离障碍范畴，与精神分裂症是不同诊断。把两者混为一谈会造成对患者的误解和污名。

资料说明

以上为一般科普描述，不提供个体诊断。若本人或家人出现持续的现实判断困难、行为显著改变或日常功能明显受损，应尽快联系精神科/心理健康专业服务；如有即时安全风险，应联系当地急救或危机服务。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）

3. 发病流行病学

> 流行病学数据是群体统计，不用于判断某个人是否患病。不同研究的诊断标准、调查年份、年龄范围和统计方法不同，数字不宜直接横向比较。

3.1 患病人数与疾病负担

世界卫生组织估计，全球约 **1/300 人**（约 2700 万人）患有精神分裂症；成人中的估计比例约为 **1/222**。这些是全球层面的估计，不等于任一国家、地区或年龄组的实际比例。

该疾病可对学习、工作、人际关系、独立生活和身体健康造成不同程度影响。世界卫生组织将其列为可导致显著功能受损的精神障碍之一。功能结果并非由诊断名称单独决定，也受症状、共病、治疗可及性、歧视和社会支持等因素影响。

3.2 起病年龄与性别差异

精神病性症状通常在青少年后期至成年早期开始显现，但任何年龄出现新的精神病性症状都需要专业评估，不能仅依年龄排除或确认诊断。总体研究中，男性起病往往早于女性；具体年龄分布会因研究人群和定义而变化。

不同研究对男女患病比例的结论可能不同。样本来源、诊断标准、就医和识别差异都会影响统计结果，因此不宜把“男性一定更多”或“女性一定更晚发病”当作个体规律。

3.3 首次发作、复发与病程

流行病学资料中的“发病”“首次精神病性发作”“复发”和“再次住院”是不同结局，不能互相替代。复发率尤其受随访时间、症状定义、治疗和依从性等因素影响；单一百分比若没有注明人群、观察年限和研究方法，参考价值有限。

个体是否复发、何时复发无法仅凭群体统计预测。规律复诊、与医生共同制定治疗计划、尽早处理睡眠和症状变化等，是临床照护中常讨论的管理内容；不要自行停药或调整药物。

3.4 致残与功能影响

有些患者会长期面临认知、动机、人际互动、学习或就业方面的困难，也有人经过治疗与支持后能够维持较稳定的日常生活。功能受损程度存在很大差异，不能由诊断推断一个人必然失去工作能力、自理能力或社会参与能力。

“致残”在统计研究中通常描述群体层面的健康损失或功能影响，并不自动等同于某项行政认定。个人的残疾评定、福利或工作能力判断，应依据当地法规和正式评估流程。

3.5 阅读数据时的注意事项

- 区分**患病率**（某时期或某时点患病的人数比例）与**发病率**（一段时间内新发病例的频率）。
- 确认数字对应的国家/地区、年份、年龄组、诊断标准和观察周期。
- 全球估计不能直接替代中国本地调查结果。
- 统计关联不等于个体因果；群体风险不能用于给个人贴标签。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：Schizophrenia：概况与健康影响

4. 疾病分型演变

> 本页介绍诊断分类的历史变化。旧分型可用于阅读历史病历或文献，但不应自行套用来诊断他人。

4.1 传统亚型

过去的分类系统曾根据当时较突出的表现，把精神分裂症分为若干亚型。DSM-IV 等旧版 DSM 中常见的名称包括：

- **偏执型**：以妄想或幻听等为突出表现。
- **紊乱型（旧称青春型）**：思维、言语或行为紊乱较明显。
- **紧张型**：以显著的精神运动异常为突出表现，可能表现为活动显著减少、姿势维持或异常增多等。
- **未分化型**：表现符合精神分裂症诊断，但不突出符合某一特定亚型。
- **残留型**：明显急性症状减轻后，仍有一定症状或功能困难。

具体名称、定义和是否纳入分类，依诊断系统及其版本而异。旧的“偏执型”等亚型不等同于其他诊断，例如妄想障碍。

4.2 DSM-5 的变化

DSM-5（2013）取消了传统精神分裂症亚型。主要考虑包括：同一患者可能随病程在亚型之间变化；亚型在不同时间和评定者之间的稳定性有限；它们对病因、预后或治疗选择的区分能力不足。

因此，现代临床评估更重视个体当前的具体症状、严重程度、病程、功能影响和共病，而不是只用一个亚型名称概括全部情况。DSM-5-TR 沿用这一总体做法。

4.3 ICD-11 的做法

ICD-11 也不再沿用 ICD-10 中精神分裂症的传统偏执型、青春型、紧张型等亚型体系。ICD-11 的临床描述强调根据症状领域及病程等信息更细致地描述诊断；类别和可用描述应以具体版本的 ICD-11 临床指南为准。

“不再强调传统亚型”不代表症状类型不重要。临床仍会记录幻觉、妄想、阴性症状、认知或情绪方面的表现，只是不把这些表现固定成互斥且稳定的疾病亚型。

4.4 紧张症的特别说明

紧张症可表现为精神运动和行为方面的显著异常，可能与不同精神障碍或身体疾病相关。它不应被简单理解为精神分裂症专属亚型。若出现明显僵住、长时间不动、异常兴奋或反应显著减少等情况，应由医疗专业人员及时评估。

阅读旧资料的建议

阅读旧病历或文献时，应记录其采用的分类系统和版本。不要把旧诊断标签直接当作今天的亚型，也不要根据单一行为判断患者属于某种分型。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器

5. 常见名词释义

> 以下为便于理解的科普解释。各诊断系统和临床量表对术语可能有更严格的定义；术语不能代替完整评估。

5.1 阳性症状

“阳性”指相对于通常心理体验**增加或出现了异常体验**，不是“好的症状”。

- **幻觉**：在没有相应外界刺激时出现类似感知的体验，例如听到声音。幻听较常见，但幻觉也可能涉及其他感官。
- **妄想**：在相反证据充分时仍持续持有、且不符合相应文化背景的错误确信。妄想的主题可能包括被害、关系或夸大等；不能仅因某个信念听起来奇特就认定为妄想。
- **思维/言语紊乱**：思路组织或表达连贯性明显受影响，可能难以跟随谈话主题。应结合语言、文化、教育和当时情境理解。

阳性症状不是患者故意编造，也不意味着患者必然危险。评估重点是症状体验、痛苦程度、现实判断和安全需求。

5.2 阴性症状

“阴性”指某些正常功能或表达减少，并非“负面”或“消极”。常见表现包括主动性下降、言语减少、面部和声音情感表达减少、社交兴趣降低、难以体验愉悦等。

类似表现也可能由抑郁、药物镇静或其他副作用、身体疾病、睡眠问题、长期缺乏机会或社会隔离造成。医生通常需要辨别原因，不能只凭“懒散”或“沉默”判断。

5.3 认知症状

指注意力、工作记忆、信息处理速度、计划、组织和解决问题等能力方面的困难。认知表现会影响学习、工作和日常事务，但程度因人而异，也可能受睡眠、情绪、药物和身体健康影响。

5.4 前驱期

指明显精神病性发作前，可能出现的非特异性变化阶段，例如睡眠或学习工作状态改变、社交减少、注意困难或轻微可疑体验。许多这些变化也常见于没有发展为精神分裂症的人，因此“前驱期”并不是仅

靠自我观察就能确认的诊断，也不意味着之后必然发病。

若变化持续、加重并影响生活，宜咨询专业人员，而非自行贴上“前驱期”标签。

5.5 发作期

通常指症状明显加重、达到临床需要积极评估或治疗的阶段。不同指南对“急性发作”或“活动期”的界定可能不同；它不一定意味着患者会住院，也不应用作对个人状态的自行判断。

5.6 缓解期

指部分或大部分症状在一段时间内减轻的阶段。缓解不一定意味着所有症状消失，也不代表可以自行停药或停止随访。是否调整治疗应由患者与治疗团队共同讨论。

5.7 残留状态

旧版分类和临床描述中使用“残留”来指明显急性症状缓解后仍持续存在的部分症状或功能困难。它描述的是一段临床状态，不表示患者“没有希望”或必然无法恢复；现行分类中具体术语和使用方式可能不同。

5.8 症状、诊断与功能并非一回事

症状是个体在某一时期的体验或表现；诊断需要专业人员综合症状、持续时间、病程、功能变化和其他可能原因；功能则涉及自理、学习、工作、人际和社会参与等实际生活方面。三者相关，但不能互相简单替代。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）

1. 遗传因素

> **核心结论：**遗传会影响精神分裂症的易感性，但不是“父母有，孩子就一定会患病”。遗传风险是概率性的、多基因的，并与发育过程和环境共同作用。

1.1 家族研究说明什么

流行病学研究发现，精神分裂症患者的生物学亲属平均风险高于没有家族史的人群；亲缘关系越近，群体层面的遗传相关性通常越高。这提示遗传因素参与发病，但不能由家族史单独预测某位亲属是否发病。

家族成员还可能共享生活环境、社会处境和压力经历，因此家族聚集并不等于全部关联都由基因造成。个体诊断仍需依据临床表现和病程进行专业评估。

1.2 双生子与家系研究

双生子研究比较遗传相似程度不同的双生子在疾病上的共同出现情况。同卵双生子共享几乎全部遗传变异，异卵双生子平均共享约一半常见遗传变异。若同卵双生子的共同患病率高于异卵双生子，说明遗传因素对群体差异有贡献。

但同卵双生子并非必然同时患病。即使遗传背景非常接近，仍可能出现一人患病、另一人不患病的情况。这正说明基因并非一份确定的“命运清单”。双生子研究的估计还受样本量、诊断方式和研究假设影响，不能直接换算成某个家庭的个人患病概率。

1.3 多基因风险，而非单一“精神分裂症基因”

目前研究总体支持精神分裂症具有高度多基因性：许多遗传变异各自只带来很小的风险变化，多个常见变异以及少数较罕见变异共同参与易感性。大多数风险变异并非只与一种疾病相关，也不会单独决定是否发病。

遗传研究识别的是群体统计关联或生物学线索，并不能据此用普通基因检测确诊精神分裂症。现阶段，单个基因检测或消费级基因报告不能可靠地预测个人是否会患病，也不能替代精神科评估。

1.4 基因与环境的共同作用

遗传易感性可能与孕期和出生相关因素、生活经历、物质使用、社会压力及其他生物学过程相互作用。某种暴露的影响可能因个体背景不同而异；相同遗传背景的人也可能因经历不同而有不同结果。

“遗传与环境共同作用”是理解复杂疾病的研究框架，并不意味着能准确计算某个人的发病时间或结果。

1.5 给患者与家庭的提示

- 家族史是风险信息，不是诊断，也不代表必然遗传。
- 患者或家属不应因疾病互相归咎；患病不是任何人的过错。
- 不建议用未经验证的基因检测结果作生育、治疗或歧视性决策。
- 若家庭成员有持续的精神健康困扰，可寻求专业咨询；是否需要评估由实际症状和功能变化决定，而不是只看家族史。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- Trubetskoy V, et al. **Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia.** *Nature*. 2022;604:502–508. doi:10.1038/s41586-022-04434-5
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)

2. 大脑生物学机制

> **核心结论：**精神分裂症没有已被证实的单一脑部病因。多巴胺、谷氨酸、脑发育和神经网络等研究提供了部分解释，但都不能单独说明所有患者的症状和病程。

2.1 多巴胺相关模型

多巴胺参与动机、学习、奖赏和对重要信息的判断。研究发现，部分患者在某些脑通路（尤其与纹状体相关的通路）存在多巴胺合成或释放调节异常的证据。这促成了多巴胺相关假说，常用于解释某些精神病性症状的形成。

这不等于“全脑多巴胺都过多”。不同脑区、通路、症状和个体之间可能存在差异；多巴胺模型也不能独自解释阴性症状、认知困难或疾病的全部病程。抗精神病药对多巴胺受体的作用是治疗机制研究的一部分，但药物有效并不能证明疾病只有这一种病因。

2.2 谷氨酸与其他神经递质

谷氨酸是中枢神经系统的重要兴奋性神经递质。围绕 NMDA 型谷氨酸受体及其与多巴胺、GABA 等系统相互作用的研究，提出了谷氨酸相关模型。动物研究、药理学观察和部分人体研究提供了线索，但目前仍不足以形成一个能够解释所有患者、并直接指导常规个体诊断的单一机制。

乙酰胆碱、GABA、血清素以及神经免疫、突触发育和可塑性等过程也在研究中。它们可能彼此影响，而不是互相排斥的独立答案。

2.3 神经发育与脑网络

一种重要研究观点认为，遗传易感性与某些早期生物学或环境因素可能影响大脑发育、突触连接和网络成熟；在之后的发育阶段，压力、睡眠紊乱、物质使用或其他因素可能与症状显现有关。这是解释部分研究现象的框架，不表示能从个人经历反推出确定病因。

脑影像研究在群体层面报告过平均结构或功能差异，例如海马、前额叶及相关网络的变化。但研究结果存在个体差异、样本和方法差异，也可能受到病程、共病、吸烟、药物和社会因素影响。影像差异并非精神分裂症特有，目前不能用一次脑部扫描确诊或排除精神分裂症。

2.4 从脑机制研究到临床应用

现有机制研究有助于提出假说、识别潜在治疗靶点和理解症状，但多数发现仍是研究层面的群体规律。临床诊断主要依据专业访谈、症状与病程、功能变化，并排查其他精神、神经或身体疾病；不是通过测量某种神经递质或单一影像指标完成。

因此，科普中宜说“与某些生物学过程有关”“研究提示”，避免说成“就是某种物质太多/太少”或“某个脑区坏了”。

参考来源

- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)
- Howes OD, Kapur S. **The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III—the final common pathway.** *Schizophrenia Bulletin*. 2009;35(3):549–562. doi:10.1093/schbul/sbp006
- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单

3. 环境诱因

> **先说明：** “风险因素”表示在群体研究中与更高概率相关，不代表它必然导致疾病。多数接触某一风险因素的人不会因此必然患精神分裂症；很多患者也找不到一个明确、单一的诱因。

3.1 孕期与围产期因素

研究考察过孕期感染、营养或健康问题、早产、低出生体重及围产期缺氧等因素。这些研究多为观察性研究，因素之间可能相互关联，也可能受家庭、社会和其他健康状况影响。不能由某位患者的病情反推母亲曾有某种经历，更不应据此责怪父母。

这些群体层面的关联也不表示孕期发生某种常见疾病或分娩并发症就会导致精神分裂症。具体因果路径及其对个人的影响尚未完全厘清。

3.2 童年逆境与创伤经历

童年虐待、忽视、欺凌、家庭暴力或其他严重逆境，在一些研究中与之后精神健康问题（包括精神病性体验）的风险增加相关。研究中的关联可能涉及长期应激反应、社会支持、后续心理健康和其他共同因素；并非每位经历逆境的人都会患精神分裂症，也不是所有患者都有相关经历。

讨论创伤时应尊重当事人意愿，不把创伤当作唯一解释，也避免要求患者公开不愿分享的经历。

3.3 大麻及其他精神活性物质

大麻使用与精神病性症状风险存在关联，尤其是较早开始、频繁使用或使用高 THC 浓度产品时，研究观察到的风险通常更值得关注。不同研究设计和人群得到的估计并不完全一致；遗传或既有精神健康脆弱性、使用方式及社会背景也可能共同影响结果。相关性本身不能说明每个使用者都会发病，或每个患者的病因都是大麻。

安非他明、可卡因、致幻剂等物质，以及某些处方药或非处方药，也可能诱发或加重精神病性症状。出现相关症状时，医疗评估需要了解物质及药物使用情况；不要自行停用处方药，应联系开药医生。

3.4 城市环境、压力与社会处境

居住环境、社会经济不利、歧视、迁移经历、社会孤立和长期压力等因素在部分研究中与精神病性障碍风险或病程相关。这些因素相互交织，可能同时影响暴露、健康、就医机会和被诊断的概率，因果方向并不总是清楚。

“生活压力大”不能用来解释或归咎某个患者，也不能单凭压力经历预测发病。支持性关系、稳定住房、可及的医疗服务和减少歧视，可能有助于整体健康和康复，但不能保证疾病不会发生。

3.5 如何正确理解“诱因”

- 风险因素不是充分条件；存在风险不等于必然患病。
- 病因通常是多种因素共同作用，风险因素也可能彼此相关。
- 同一个因素对不同人的作用可能不同。
- 不应把疾病归咎于母亲、家庭教养、性格或患者个人选择。
- 减少可改变的健康风险（例如避免非医疗用途的精神活性物质）有一般健康意义，但不能替代专业评估或治疗。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- Marconi A, et al. **Meta-analysis of the Association Between the Level of Cannabis Use and Risk of Psychosis.** *Schizophrenia Bulletin*. 2016;42(5):1262–1269. doi:10.1093/schbul/sbw003
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)

4. 心理社会因素

> **重要澄清：**精神分裂症不是“想不开”“性格差”或家教失败造成的。心理社会经历可能与风险、症状体验、就医和康复有关，但不能把复杂疾病简化成单一心理原因。

4.1 压力—易感性：一个解释框架

研究和临床讨论有时会使用“压力—易感性”框架：个体的生物学易感性与生活中的压力、睡眠变化、健康状况和社会环境可能相互作用。它是帮助理解风险差异的框架，不是一条可用于预测个人发病的定律，也不能将每次发作都归因于某一件压力事件。

相同的压力对不同人影响不同；很多经历重大压力的人不会发展为精神分裂症，很多患者也未发现明显的单一压力源。

4.2 创伤、歧视与社会压力

童年逆境、持续欺凌、暴力、歧视、社会排斥和经济困难等经历，在部分研究中与精神病性体验或较差健康结果相关。关联可能受到其他共同因素影响，因此不能据此确定个体病因。

歧视和污名还可能带来羞耻、孤立、延迟求助和医疗服务障碍。减少歧视、尊重患者自主权、提供安全稳定的支持环境，是公共卫生和康复工作的重要部分，而不是对疾病病因的指责。

4.3 家庭关系与“家属责备”

家庭沟通方式、冲突和支持状况可能影响压力水平、治疗参与和康复环境；但这不等于家人“造成了疾病”。家庭教育或父母性格不能作为精神分裂症的单一病因。把责任推给患者或家属会增加污名、破坏信任，也无助于治疗。

家庭干预的目的通常是增进疾病知识、改善沟通、识别需要专业帮助的变化并减轻照护负担，而不是寻找“谁导致了疾病”。患者和家属可在专业人员支持下共同讨论适合的做法。

4.4 心理社会支持的作用与边界

稳定的住房、可及的医疗服务、社会支持、学习和就业支持，以及针对性的心理社会干预，可能帮助改善生活质量、社会功能和康复体验。它们不能被误解为单靠积极思考就能消除疾病，也不能替代必要的精神科评估和治疗。

同样，出现精神分裂症相关症状并非个人意志薄弱。鼓励求助和共同决策，比要求患者“振作起来”或用道德评价解释症状更有帮助。

交流建议

- 使用“患有精神分裂症的人”或当事人偏好的称呼，避免贬损标签。
- 倾听当事人的体验，不嘲笑、不争辩其感受，也不必认同无法核实的解释。
- 询问对方需要何种支持，尊重隐私和选择。
- 若症状变化明显或安全受到威胁，联系精神科专业服务或当地紧急支持。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)

5. 目前研究局限

> **总体结论：**精神分裂症的病因尚未完全阐明。现有证据支持多种遗传、生物学、发育和环境因素可能共同参与，但还没有一个机制能够解释所有患者，也没有一种检查可据此预测某个人必然发病。

5.1 复杂因素难以拆分

遗传背景、发育、身体健康、物质使用、创伤、社会压力和医疗可及性可能彼此关联。观察到两种因素同时出现，并不能单独证明其中一种导致另一种。某个风险因素也可能只是多个关联因素中的一环。

发病往往不是单一时点或单一事件造成。患者在症状出现前的经历可能难以完整测量，回顾性报告也可能受记忆和当下状态影响。

5.2 研究人群和诊断异质性

“精神分裂症”诊断涵盖多种症状组合、严重程度、病程和功能结果。不同研究使用的诊断标准、招募人群、随访时间和结局指标可能不同，因此结果未必能直接比较。

遗传和脑影像研究常需要很大的样本才能发现稳定的小效应。样本来源和祖源代表性不足、研究方法不同或未能充分重复验证，都可能限制结果向其他人群推广。

5.3 相关不等于因果

许多环境因素来自观察性研究，无法像受控实验那样随机分配。潜在混杂因素、反向因果和测量误差可能影响结果。例如，早期症状可能先影响社交和物质使用；若只观察后续同时出现的事件，就可能误判先后关系。

因此，研究报告中的“风险增加”通常指特定群体和条件下的统计关联，并不说明某个因素是必要条件或充分原因。

5.4 机制模型各有边界

- **多巴胺模型：**有重要实验和药理学依据，但不足以解释全部症状、认知差异和病程。
- **谷氨酸及其他神经递质模型：**提供值得研究的机制线索，部分证据仍处于发展阶段，不能简单转化为个人诊断。
- **脑影像发现：**通常是群体平均差异，个体之间重叠明显，尚无单一影像特征可用于常规确诊。

- **遗传研究：**显示复杂的多基因贡献，但风险变异不能决定个人命运，也不等于可用于普通临床筛查的基因检测。

这些模型可以互相补充；目前没有理由把其中任何一个说成已完整揭示疾病本质。

5.5 从研究结果到临床应用仍有距离

候选生物标志物或统计模型可能在研究样本中表现出关联，但要用于临床，还需证明在不同人群中可重复、准确、能改善诊疗决策，并评估误报、漏报和隐私等问题。目前诊断仍依赖专业临床评估，而非单项基因、血液或脑影像检查。

“发现一个可能的通路”也不等于已经找到可安全有效的治疗。治疗决策需要独立的临床证据和个体化风险—获益评估。

5.6 如何阅读病因研究

阅读资料时建议核对：

1. 研究是观察性研究、实验研究、系统综述还是临床指南？
2. 研究对象和样本量如何，结果是否在独立样本中重复？
3. 报告的是相关性、风险预测，还是已有较强因果证据？
4. 结果适用于哪一人群、哪种诊断标准和时间范围？
5. 作者是否说明局限、资金来源和利益冲突？

对尚未确立的机制，应标注“研究假说”或“尚在研究，未用于常规临床”，避免把新闻标题或动物实验结论写成患者的确定病因。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. **Schizophrenia.** *The Lancet*. 2016;388(10039):86–97. doi:10.1016/S0140-6736(15)01121-601121-6)
- Trubetskoy V, et al. **Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia.** *Nature*. 2022;604:502–508. doi:10.1038/s41586-022-04434-5

3.1 阳性症状（“多出”的体验）

> “阳性”在精神医学中指相对于通常状态新增或明显增强的体验，不代表“好”。下列内容用于理解症状，不是自我诊断清单。

幻觉

幻觉是在没有相应外界刺激时出现的感知体验。幻听是精神病性障碍中常见的一类体验，也可能出现视觉、嗅觉、触觉或其他感官体验。幻觉对当事人而言可能非常真实，并可能带来恐惧、困惑、羞耻或睡眠困难。

了解幻觉时，专业人员会关注其出现的时间、频率、内容、当事人如何理解、是否影响日常生活，以及是否带来安全风险。出现幻觉并不自动等于精神分裂症；睡眠剥夺、物质或药物影响、神经系统疾病、情绪障碍等也可能相关。

妄想

妄想是持续的错误确信，通常难以被相反证据纠正，且不能用当事人的文化背景或共同信念充分解释。常见主题包括：

- **被害妄想**：坚信自己正被伤害、监视或针对。
- **关系妄想**：把中性的谈话、新闻或环境线索理解为专门针对自己。
- **夸大妄想**：坚信自己拥有特殊身份、能力或使命。
- **钟情妄想**：坚信某人爱慕自己，即使缺少相应证据。

这些名称描述的是主题，不代表仅凭一句话就能判定妄想。评估需结合确信程度、持续时间、文化背景、现实证据和整体病程。

思维、言语与行为紊乱

当思维组织受到明显影响时，谈话可能突然转题、难以跟随、表达松散或答非所问。行为可能变得难以理解、缺乏目标或不适合当时情境。疲劳、语言差异、认知障碍、药物影响和其他疾病也可能影响表达与行为，应由专业人员综合判断。

紧张症相关表现

紧张症涉及明显的精神运动或行为异常，可能包括活动显著减少、长时间维持姿势、对指令反应减少，或相反地出现无目的的显著躁动。它可与不同精神或身体疾病相关，并非精神分裂症所独有。若出现突然僵住、意识或反应显著改变、无法进食饮水等情况，应及时就医。

如何支持正在经历症状的人

- 保持语气平静，确认对方正在经历痛苦，但无需争辩或认同无法核实的解释。
- 简短询问：“你现在安全吗？”“需要我陪你联系医生吗？”
- 尽量减少围观、争吵和过度刺激，尊重个人空间。
- 若症状突然出现、快速恶化、伴随意识混乱或安全风险，尽快寻求专业或紧急医疗帮助。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）

3.2 阴性症状（某些功能的减少）

> “阴性”不是负面或消极，而是指某些通常存在的表达、动机或行为减少。症状表现因人而异，不宜用“懒”“不在乎”等道德标签解释。

常见表现

- **情感表达减少**：面部表情、眼神、语调或情绪反应看起来较少。
- **言语减少**：自发说话较少，回答简短，但不一定代表没有想法或不愿沟通。
- **意志/动机下降**：开始并持续日常活动较困难，例如洗漱、做饭、处理事务或完成学习任务。
- **快感体验减少**：对以往喜欢的活动较难感到兴趣或愉悦。
- **社交兴趣或主动性减少**：较少主动联系他人或参与活动；可能伴随孤独，也可能并非本人不需要关系。

这些表现不一定同时出现，也可能随病程、压力和治疗状态变化。

原发与继发因素

临床上会区分可能直接与疾病过程相关的阴性症状和由其他原因造成或加重的“继发性”表现。可能需要排查：

- 抑郁、焦虑、睡眠问题或身体疾病；
- 药物导致的镇静、动作迟缓或其他不适；
- 阳性症状带来的害怕和回避；
- 缺乏安全住房、教育就业机会、社会接触或日常结构；
- 物质使用及其相关问题。

因此，看到一个人少说话、少出门或行动慢，不能直接判断是阴性症状，也不应自行停药。应把具体变化、发生时间和对生活的影响告知治疗团队。

对日常支持的启示

与其笼统催促“积极一点”，不如把目标拆小、具体并共同商量，例如固定一个起床时间、完成一项简单家务或逐步恢复一项兴趣。给予等待和鼓励，避免替当事人做所有决定；同时注意疲劳、药物不适和情绪问题，必要时与专业人员讨论。

阴性症状可能影响功能，但并不决定一个人的能力、价值或未来。支持应以本人目标和实际需要为基础。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- Galderisi S, et al. **EPA guidance on assessment of negative symptoms in schizophrenia.** *European Psychiatry*. 2021;64(1):e23. doi:10.1192/j.eurpsy.2021.11

3.3 认知困难（可能影响学习与日常生活）

认知指获取、处理、储存和使用信息的能力。部分精神分裂症患者会遇到认知困难，但程度和组合因人而异；这不是智力、努力程度或人格的简单反映。

常涉及的能力

- **注意与专注**：较难持续听讲、阅读或完成多步骤任务。
- **处理速度**：理解信息、回应或在任务间切换需要更多时间。
- **工作记忆**：短时间记住并操作信息较困难，例如边听边执行多个步骤。
- **学习与记忆**：学习新内容或之后回忆细节可能更费力。
- **执行功能**：计划、排序、判断优先级、监控进度和解决问题可能受影响。
- **社会认知**：理解语气、面部表情或他人意图等社交线索可能较困难，但个体差异很大。

对功能的影响

这些困难可能使上课、工作、管理日程、处理账单、记住预约或维持复杂社交变得更费力。表现会受到睡眠、情绪、压力、身体健康、药物副作用、教育经历和环境支持影响。一次表现不佳不能说明能力永久下降。

评估与支持

治疗团队可能通过访谈、功能评估或适当的标准化测验了解认知状况。量表或测验结果需要结合教育、语言、文化和当时状态解释，不是单独诊断精神分裂症的工具。

实用支持可以包括：将复杂任务拆成步骤、使用日历和提醒、减少同时进行的任务、安排规律休息、用清晰直接的表达确认理解，以及提供循序渐进的学习或工作支持。具体康复目标应与本人共同制定。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management

3.4 情绪相关表现

精神分裂症病程中可能同时出现抑郁、焦虑、易激惹、恐惧、情绪反应减少或睡眠改变。情绪症状可在不同阶段出现，也可能与其他精神障碍、身体疾病、生活压力或治疗因素有关，需要单独评估。

常见情况

- **抑郁和低落：**情绪低落、兴趣下降、无望感、精力不足，可能影响治疗参与和生活功能。
- **焦虑与恐惧：**可能与不确定感、幻觉或妄想体验、社交困难、环境变化或其他焦虑问题有关。
- **易激惹：**可能伴随压力、睡眠不足、恐惧、症状变化或药物不适，不应简单解读为“脾气差”。
- **情绪表达减少：**外在表情和语调较少，不必然说明内在没有情绪或不在乎。
- **睡眠与精力变化：**可能先于症状变化，也可能由情绪问题、作息、身体疾病或药物影响。

为什么要鉴别

情绪低落、退缩、动作迟缓可能与阴性症状重叠；焦虑和激越也可能与药物副作用、物质使用、身体不适或精神病性体验相关。新出现的显著情绪波动、连续失眠、异常精力增高或明显绝望感，尤其伴有自伤想法时，应及时告知专业人员。

评估时可记录变化何时开始、持续多久、睡眠和用药情况、生活事件及功能影响。不要自行将所有情绪变化归因于精神分裂症，也不要自行加减药物。

何时尽快求助

如果当事人表示想伤害自己或他人、无法保证基本安全，或情绪和行为迅速恶化，应立即联系当地急救、精神科急诊或危机服务；在等待帮助时尽量由可信任的人陪伴，并减少其接触可能造成伤害的物品。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management
- 世界卫生组织：Suicide fact sheet

3.5 病程阶段与临床状态

> “前驱期、急性发作期、巩固期、维持期”是帮助理解病程和服务需求的常用描述，并非每个人都会依次经历同样阶段。不同指南、研究和临床服务对阶段名称及界限可能不同。

前驱或高风险阶段

有些人在明显精神病性发作前会出现睡眠、学习工作、社交或情绪方面的变化，也可能出现轻微、短暂且不确定的异常体验。这些表现并不特异，许多人不会发展为精神病性障碍，不能据此自行诊断。

如果变化持续、加重并影响功能，可向精神卫生专业服务咨询。评估重点是早期支持和排除其他原因，而不是给个人贴标签。

首次发作或症状明显加重阶段

当幻觉、妄想、思维紊乱或行为变化显著影响安全和日常生活时，需要尽快专业评估。临床团队会了解症状、既往情况、身体健康、药物及物质使用，并与当事人讨论合适的治疗和支持。是否需要住院取决于医疗需要、安全和当地法律程序，不由某个单一症状决定。

症状稳定与巩固阶段

症状开始改善后，仍可能需要继续治疗、观察不良反应、恢复作息和重建日常活动。此阶段的目标通常包括维持改善、识别个人复发信号、处理身体健康问题，并逐步恢复社交、学习或工作。

维持与康复阶段

稳定期也可能有残余症状、认知困难或社会功能挑战。持续随访和支持有助于及时调整计划；治疗持续时间和方式需由患者与治疗团队共同决定。康复关注的不仅是症状，也包括本人重视的生活目标、关系、教育、就业和独立生活。

复发与缓解并非线性过程

病程可能波动，也可能长期相对稳定；复发不等于治疗失败，缓解也不意味着可以自行停止治疗。阶段变化因人而异，宜用具体症状、功能和生活需要描述，而不是把人固定称为某一“类型”。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management

1. 诊断标准

> **诊断须由具备相应资质的专业人员作出。**本页概述分类系统的作用，不复制诊断手册原文，也不能用作自测标准。具体条款以实际采用的分类系统和版本为准。

1.1 ICD-11 与 DSM-5

ICD-11（世界卫生组织国际疾病分类第 11 版）和 DSM-5/DSM-5-TR（美国精神医学学会诊断手册）都将精神分裂症归在精神障碍分类中，但编排、术语、编码用途和部分诊断要求并不完全相同。ICD 主要服务于国际健康信息记录、统计和诊断分类；DSM 主要用于临床诊断和研究语境。各地实际采用版本依当地政策。

1.2 诊断评估的一般要素

专业评估通常综合考察：

- 是否存在妄想、幻觉、思维/言语紊乱、行为明显紊乱或阴性症状等表现；
- 症状的持续时间、频率、严重程度及相互关系；
- 症状是否影响学习、工作、自理、人际关系或其他重要功能；
- 情绪发作、物质或药物影响、身体/神经系统疾病及发育史等其他解释；
- 既往病程、治疗反应和来自当事人同意的补充资料。

诊断不是仅凭“听到声音”、一个量表分数、一张影像或家属描述作出；需要形成完整的临床判断。

1.3 需要排查的其他原因

精神病性症状也可出现在双相障碍或重度抑郁等情绪障碍、物质或药物影响、神经系统疾病、感染、代谢异常及其他状况中。首次出现、起病突然、伴意识或认知明显改变、出现新发神经体征，或症状与既往模式显著不同，都需要及时评估身体和神经方面原因。

1.4 不能自行诊断的原因

睡眠不足、创伤、焦虑、药物副作用和其他健康状况都可能造成与精神病性症状相似的体验；反过来，部分患者也不容易主动描述症状。自测问卷只能提供有限信息，无法完成鉴别诊断和风险评估。

如果担心本人或家人出现相关症状，可记录开始时间、变化、睡眠、用药和物质使用情况，并尽早预约精神科或其他专业服务。不要因阅读诊断条目自行贴标签或改变处方。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- American Psychiatric Association：DSM
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management

2. 诊断流程

> 诊断流程会因症状、年龄、身体状况和医疗机构而异。检查的目的是理解症状、评估安全与功能，并排除可能的身体或物质相关原因；并非每个人都需要同一套检查。

2.1 初步接触与紧急情况判断

专业人员会先了解目前最困扰的问题、何时开始、变化快慢、对睡眠和日常生活的影响，以及是否存在自伤、伤人、无法照顾基本需要或其他即时危险。若存在紧急风险，应优先保障安全并获得急诊帮助。

2.2 病史与精神状态评估

评估可能涉及：

- 当前和过去的情绪、思维、感知、行为与睡眠变化；
- 症状的持续时间、发生情境、对生活和关系的影响；
- 既往精神和身体疾病、用药、物质使用、治疗经历；
- 发育、教育、工作、家庭和社会支持情况；
- 当事人希望解决的问题、个人优势和康复目标。

经本人同意，家属或其他可信任者可以补充观察到的变化；家属信息是补充，不应取代当事人的参与和表达。

2.3 身体检查与辅助检查

医生会根据病史和临床表现决定是否进行体格或神经系统检查、实验室检查、药物或物质相关检测，以及影像或其他检查。可能考虑的原因包括代谢或内分泌问题、感染、癫痫、神经系统疾病和处方药影响等。

抽血、脑影像或其他检查不是精神分裂症的“确诊试纸”。没有某一项常规检查可以单独确诊；是否检查、检查什么应由临床需要决定。

2.4 鉴别诊断与持续观察

如果病程信息暂不充分，专业人员可能先记录症状或工作诊断，在随访中观察变化，而不是过早下定论。需要结合情绪发作与精神病性症状的时间关系、物质或药物暴露、发育特点和身体健康，判断更合

适的诊断解释。

2.5 共同制定后续计划

完成评估后，专业人员通常会与当事人讨论诊断理解、治疗选择、潜在获益与风险、复诊安排和危机时的求助方式。患者可以提出问题、表达偏好；如对评估结果有疑问，可询问诊断依据或寻求进一步专业意见。

就诊前可准备

- 按时间顺序写下症状和生活功能的变化；
- 整理正在使用的处方药、非处方药和补充剂；
- 如适用，记录酒精或其他物质使用情况，尽量如实告知医生；
- 带上既往病历或检查结果；只分享本人愿意分享且与评估相关的信息。

参考来源

- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management
- 世界卫生组织：mhGAP guideline

3. 鉴别诊断

> 出现幻觉、妄想或行为改变并不自动意味着精神分裂症。鉴别诊断是专业人员结合完整病史、症状、时间线和检查结果进行的临床工作。

3.1 情绪障碍伴精神病性症状

- **双相障碍**：需要了解躁狂/轻躁狂和抑郁发作的病程，以及精神病性症状与情绪发作之间的时间关系。
- **重度抑郁障碍伴精神病性症状**：抑郁发作、功能变化及精神病性症状的关系有助于鉴别。
- **分裂情感性障碍**：评估情绪发作与精神病性症状在整个病程中的关系。诊断要求依所采用的分类系统而定。

情绪低落、兴奋或易激惹本身不足以判断属于哪种疾病。

3.2 物质或药物相关的精神病性症状

大麻、兴奋剂、致幻剂等物质，以及部分处方药或停药过程，可能诱发或加重精神病性症状。需了解使用的物质、剂量、时间线和停用后的变化。不要为验证原因自行使用或停用任何物质或处方药。

3.3 身体与神经系统原因

脑炎、癫痫、脑外伤、肿瘤或血管事件，以及代谢、内分泌、感染、睡眠等问题，可能伴随精神状态或行为变化。首次发病、突然起病、意识混乱、发热、抽搐、新发神经体征或高龄首次出现相关症状时，尤其需要及时医学评估。

是否需要抽血、脑电图、影像或其他检查取决于临床表现，不是每位患者都需要相同检查。

3.4 其他精神与神经发育状况

- **妄想障碍**：妄想表现及整体功能情况与精神分裂症可能不同，需要结合完整症状判断。
- **解离性障碍**：可能涉及身份、记忆或意识连续性方面的体验，与精神分裂症不是同一诊断。
- **自闭症谱系障碍**：社交沟通和行为特征通常具有发育史背景；若出现新的精神病性症状，还需单独评估。

- **创伤相关障碍、人格障碍、强迫症和其他状况：**某些体验或行为可能表面相似，但成因和治疗重点不同。

3.5 为什么要看时间线和功能变化

相同表象可能来自不同原因。临床人员会了解症状什么时候开始、是否与情绪发作或物质暴露同步、是否持续存在、此前的发育与功能情况，以及身体检查结果。必要时会随访更新诊断。

重要提示

不要依据网络描述给自己或他人下结论。出现突然的意识改变、无法照顾基本需要或即时安全风险时，应优先寻求急诊或当地紧急帮助。

参考来源

- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- 世界卫生组织：mhGAP guideline

4. 评估量表简介

> **量表用于辅助评估和追踪，不等于诊断。**分数受评估者培训、语言文化、症状状态和评估时间影响，应由受训专业人员解释。

4.1 PANSS

阳性与阴性症状量表（Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS）由专业评估者根据访谈和观察，对阳性症状、阴性症状及一般精神病理表现进行结构化评分。它常用于临床研究或症状变化评估。

PANSS 不是患者独立填写后即可确诊的测试；总分也不能单独决定诊断、治疗方案或是否住院。

4.2 SAPS 与 SANS

- **SAPS（阳性症状评定量表）：**重点评估幻觉、妄想、行为紊乱等阳性表现。
- **SANS（阴性症状评定量表）：**重点评估情感表达、言语、动机和社交等阴性表现。

这类量表帮助临床人员系统记录症状领域，但可能需要结合较新的评估框架、认知和功能指标使用。量表覆盖范围、版本和评分方法不同，应留意研究或病历所采用的具体版本。

4.3 认知与功能评估

若关注注意、记忆、执行功能或日常生活能力，可能使用专门的认知测验、功能量表、访谈或实际任务评估。测验表现可能受到教育、语言、文化、疲劳和情绪影响，应结合个人背景解读。

4.4 正确使用原则

1. 由受训人员按规范实施和评分。
2. 把分数与访谈、病史、观察和日常功能结合。
3. 纵向比较时尽量使用同一量表、相近条件，并记录评估时间。
4. 不用单次分数给患者贴标签，也不将量表当作预测暴力、自杀或个人命运的工具。

参考来源

- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management

- Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. **The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia.** *Schizophrenia Bulletin*. 1987;13(2):261–276. doi:10.1093/schbul/13.2.261
- Andreasen NC. **The Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS).** University of Iowa; 1984.

5.1 药物治疗

> **用药必须由精神科专业人员与患者共同决定。**本页是一般科普，不提供药物选择、剂量、换药或停药方案。不同药物的适应证、可及性和监管要求因地区而异。

治疗目标与选择

抗精神病药是精神分裂症治疗的重要组成部分，可帮助减轻或控制部分精神病性症状并降低复发风险。药物对症状领域的效果不同，对阴性症状、认知和社会功能的帮助也不完全相同。选择时需考虑既往治疗反应、症状、身体健康、潜在不良反应、个人偏好、费用和可及性，并定期复核获益与负担。

第一代（传统）和第二代（非典型）是历史上常用的分类，并不表示第二代对每个人都更有效或更安全。不同药物在运动系统、体重和代谢、泌乳素、镇静、心脏电活动等方面的风险各不相同，不能只按“代际”判断。

常见不良反应与监测

可能出现的不良反应包括嗜睡或镇静、体重增加、血糖或血脂变化、泌乳素升高、动作迟缓或僵硬、静坐不能、震颤、口干、便秘和心电活动变化等。并非每种药都会引起所有反应，严重程度也因人而异。

开始或调整治疗时，医生可能根据具体药物和个人风险，评估体重、血压、血糖、血脂、运动系统症状、月经/性功能相关问题及其他身体指标。患者应报告新出现或难以忍受的不适；严重便秘、发热伴肌肉僵硬、意识异常、晕厥或严重过敏反应等应及时就医。

长效针剂

长效注射剂通过较长间隔给药，可作为部分患者的治疗选择。可能适用于本人偏好、口服药管理困难、既往漏服与复发相关，或需要更稳定给药安排等情形。它不是“强制治疗”或适合所有人的方案；应与医生讨论具体药物、注射间隔、起始安排、潜在不良反应和个人意愿。

疗效不足时的评估

症状持续时，医生通常会先复核诊断、药物是否按计划使用、剂量和疗程是否足够、耐受性、药物相互作用、物质使用、身体疾病及心理社会压力。在符合条件的难治性病例中，专业指南会讨论氯氮平等选择；其使用需要严格的专业评估和血液及身体监测，不能自行要求或开始。

减量、停药与辅助用药

不要自行突然停药、减量、加量或与他人交换药物。突然改变治疗可能导致症状反跳、停药不适或复发。若副作用难以忍受、计划怀孕或希望减药，应尽早与处方医生讨论，由专业人员制定个体化计划并安排观察。

抗抑郁药、抗焦虑药或情绪稳定剂有时用于合并问题或特定临床情况，但需由医生评估适应证、相互作用和风险，并非所有患者都需要。

电休克治疗（ECT）

电休克治疗是在麻醉和医疗监护下实施的专业治疗，可能在特定严重或对其他治疗反应不足的临床情形中由团队评估。它不是普通“心理治疗”，也不应与历史上不规范的做法混为一谈。适用性、预期获益、麻醉风险、短期记忆或认知影响、替代方案及同意流程，应由治疗团队向患者解释；是否使用依临床需要和当地法规。

参考来源

- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management
- 世界卫生组织：mhGAP guideline
- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单

5.2 心理社会干预

心理社会干预可与药物治疗、身体健康管理和持续随访结合，支持症状应对、社会功能和个人康复目标。适合的方式应根据本人需要、意愿、文化背景和服务可及性共同选择。

认知行为治疗（CBTp）

CBTp 是针对精神病性体验调整的认知行为治疗。治疗通常在尊重当事人体验的基础上，帮助理解困扰、识别压力与症状的关系、发展应对策略，并逐步恢复本人重视的活动。目标不是羞辱患者、强迫其放弃信念或宣称能单独“治愈”精神分裂症。

家庭干预与照护者支持

家庭干预可提供疾病知识、沟通与问题解决技巧、复发预警讨论和照护压力支持。其目的不是责怪家庭，而是增强患者与家属共同应对的能力。是否邀请家属参与需考虑患者同意、隐私和家庭安全。

社交技能与生活技能训练

通过练习沟通、日常计划、解决问题、管理事务和社交情境，帮助当事人提升实际生活能力。训练应贴近个人真实目标，而非追求统一标准。

教育、职业与社区支持

可结合病情和个人选择提供学习支持、职业康复、支持性就业、住房协助、同伴支持、社区精神卫生服务和个案管理。逐步回归学习或工作时，应考虑合理调整、稳定节奏和本人隐私偏好。

支持性心理治疗与危机应对

支持性治疗可以提供稳定的倾听、情绪支持和应对压力的空间。急性症状或安全问题明显时，需要及时精神科评估和适当治疗，单靠一般心理咨询不足以替代急诊或必要的医疗照护。

选择服务时可询问

- 服务人员是否受过相关训练，治疗目标和方法是什么？
- 预期收益、可能的不适、费用和替代选择是什么？

- 如何保护个人隐私？是否会联系家属或其他服务？
- 怎样评估进展，何时需要调整计划？

治疗应尊重当事人的知情参与和选择；任何干预都不应承诺“保证治愈”。

参考来源

- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services
- 世界卫生组织：mhGAP guideline

1. 影响预后的因素

> 精神分裂症的病程和康复结果差异很大。群体研究中的影响因素不能用于给个人预测结局，也不应被理解为患者或家属的责任。

疾病与健康因素

病程特点、症状类型与严重程度、共病状况、认知和身体健康等都可能与功能结果有关。起病年龄或前驱变化只能作为研究和临床评估的一部分，不能单独决定预后。

治疗与服务因素

及早获得合适评估和治疗、能否持续获得可接受的服务、药物疗效和耐受性、共同决策与随访连续性，可能影响症状控制和复发管理。治疗方案需要适合个人；不能把疗效不佳简单归咎于“依从性差”。

社会环境与个人目标

稳定住房、家庭和同伴支持、教育与就业机会、经济条件、社区服务、减少歧视等可能影响康复机会。个人优势、兴趣、应对方式和自主目标同样重要。诊断不等同于必然丧失自理、学习或工作的能力。

如何理解“预后”

预后不是单一结果。可分别讨论症状缓解、复发、身体健康、生活质量、自理、人际关系、学习和就业等方面；这些方面的变化未必同步。有人仍有部分症状但生活满意度提高，也有人需要较长时间和更多支持。

有帮助的做法

- 与治疗团队设定本人重视、可逐步调整的目标；
- 持续复诊，及时讨论疗效、副作用和身体健康；
- 建立适合个人的早期预警和求助计划；
- 在本人同意下，让家属或可信任者参与支持；
- 将挫折视为需要重新评估支持方案的信号，而非失败或个人过错。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services

2. 复发预警信号

> 预警信号是个人化的变化线索，不是确诊复发的标准。单个变化也可能由压力、身体疾病或药物问题造成，应结合个人基线和专业意见判断。

可能值得留意的变化

- 睡眠时间或作息明显改变，连续失眠或昼夜颠倒；
- 既往熟悉的可疑想法、声音体验或思维混乱重新出现或加重；
- 突然更加紧张、警觉、害怕或容易激惹；
- 社交、学习、工作或自我照顾较个人平时明显减少；
- 说话方式、注意力、行为组织或情绪状态发生持续变化；
- 漏服、停药、药物副作用，或酒精/其他物质使用出现变化；
- 本人、家属或治疗团队观察到与过去复发前相似的个人信号。

上述表现并不特异，不要仅凭一条判断复发，也不要以加药、减药或对抗的方式自行处理。

建立个人预警计划

在病情相对稳定时，与患者和治疗团队共同记录：

1. 本人的早期变化及通常的出现顺序；
2. 哪些支持有效、哪些做法会增加压力；
3. 日间和非工作时间联系治疗团队的方式；
4. 哪位可信任者可在本人同意下协助观察或陪同就诊；
5. 出现严重症状或安全风险时的急诊联系方式和交通安排。

记录应安全保存并尊重隐私。家属观察到变化时，可用具体、非指责的方式表达，例如“这周你睡得比平常少很多，我有些担心，要不要一起联系医生？”

何时及时联系专业人员

若熟悉症状持续加重、明显影响生活、连续严重失眠、出现明显药物不适，或本人希望获得帮助，应尽早联系治疗团队或当地精神卫生服务。若无法保证即时安全、出现严重意识改变或有迫切伤害风险，应联系当地急救/急诊服务，不要只依赖家庭观察。

参考来源

- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management
- 世界卫生组织：mhGAP guideline

3. 长期康复管理

长期管理的目标是支持症状稳定、身体健康、生活质量和个人康复目标。计划应与患者共同制定，结合治疗获益、副作用、生活安排和偏好定期复核。

持续随访与共同决策

按约复诊有助于回顾症状、功能、睡眠、身体健康和治疗体验。就诊时可主动讨论副作用、费用、服药困难、怀孕计划、工作学习安排或希望尝试的非药物支持。不要因病情稳定或副作用自行突然停药。

身体健康

精神健康照护也包括一般身体健康，例如规律体检、营养、活动、睡眠、口腔健康、吸烟和代谢指标。可从小而可持续的改变开始，并结合药物影响咨询医生。出现身体症状应按需要看相应医疗专业人员，不能全部归因于精神疾病或药物。

作息与压力管理

稳定的起床和睡眠时间、适量活动、规律饮食、计划休息和减少过度刺激可能支持整体状态。压力管理可以包括放松练习、问题解决、兴趣活动、同伴支持或心理治疗；效果因人而异，不替代医疗照护。

酒精与其他物质

酒精、大麻及其他精神活性物质可能干扰症状、睡眠、判断和药物安全。若难以减少或停止使用，可向医生或成瘾服务寻求帮助；如已形成依赖，停止某些物质可能需要专业支持。应诚实告知治疗团队，以便评估相互作用和风险。

个人康复计划

可与治疗团队及可信任者共同写下：

- 本人重视的目标和已有优势；
- 日常支持及药物/其他治疗安排；
- 个人预警信号与应对方式；
- 出现副作用或复发疑虑时的联系方式；
- 紧急情况下的求助计划。

计划应定期更新，保留本人自主权；必要时可仅分享给本人授权的人。

参考来源

- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services
- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单

4. 社会功能康复

社会功能康复帮助当事人在日常生活、关系、教育和工作中逐步实现自己重视的目标。目标不是强迫“恢复正常”，而是提供适合的支持、选择和参与机会。

日常生活与独立能力

可按个人需要练习或支持购物、做饭、清洁、个人卫生、管理日程、交通和财务等事务。将任务拆成小步骤、使用提醒工具、提供示范并逐渐减少协助，可能比一次安排很多任务更可行。应避免在本人有能力时过度代劳，也不要把失误当作懒惰。

社交与关系

当事人可根据意愿逐步恢复与朋友、家人或同伴的联系。社交技能训练、同伴支持、兴趣小组或家庭沟通支持可能有帮助。应尊重个人边界和隐私，不强迫参加活动。

教育与就业

学习或工作安排可考虑渐进返校/复工、灵活时间、任务拆分、固定联系人、减少不必要的刺激和合理休息。支持性就业或教育服务可帮助匹配岗位、技能训练和工作场所支持。是否披露诊断是个人重要决定，可咨询当地专业服务了解隐私和权益。

社区与同伴支持

社区精神卫生服务、个案管理、康复机构、同伴支持和社会福利可能帮助连接住房、医疗、就业和日常资源。服务项目和资格因地区而异，应向当地正规卫生或社会服务机构查询。

制定康复目标

可采用具体、可协商、可定期复盘的目标，例如每周参加一次本人选择的活动，或逐步恢复一项家务。评价进展时关注本人感受和生活质量，不只看症状分数或他人期待。

参考来源

- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management

5. 安全风险识别与危机处理

> 风险评估需要专业人员结合个体当下情况进行。精神分裂症诊断本身不能用来判断某人会自伤或伤人；同样，风险不能仅凭一句话或单一量表排除。

需要认真对待的信号

- 当事人表达强烈绝望、想死、想伤害自己或他人；
- 已有明确计划、准备行为，或曾发生自伤/暴力行为；
- 症状快速恶化、严重失眠、极度激越、明显意识混乱；
- 因症状而无法进食饮水、无法照顾基本需要或处于危险环境；
- 近期出现重大损失、物质使用变化、药物中断或其他明显压力。

这些信号不等于必然发生伤害，但应尽快获得专业评估。直接、平静地询问“你现在有没有想伤害自己/他人？”不会替代评估，也不应因担心“提起就会诱发”而回避求助。

立即危机处理

1. 若存在迫切危险、严重受伤或意识异常，联系当地急救/急诊服务；在中国大陆可拨打 **120**。若现场存在现实的人身安全威胁，可联系当地警方 **110**。
2. 如条件允许，安排可信任的人陪伴，保持沟通简短平静，减少围观、争论和刺激。
3. 在不使任何人陷入危险的前提下，减少当事人接触可能造成伤害的物品；不要独自尝试强行控制或与其对峙。
4. 将观察到的具体情况、用药和物质使用信息告知急救或医疗人员。
5. 不要只依赖网络咨询、家属承诺或“观察几天”处理迫切风险。

若风险并非迫切但令人担忧，应尽快联系治疗团队、精神科急诊或当地精神卫生服务，讨论安全计划与后续随访。各地急救与危机服务安排不同，以所在地正式信息为准。

安全计划

在病情稳定时，可与本人和专业人员共同记录个人预警信号、有效的安抚方式、可联系的人、治疗团队和急诊渠道。安全计划应保护患者尊严与隐私，并定期更新。

参考来源

- 世界卫生组织：Suicide fact sheet
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management

1. 常见误区澄清

误区一：“精神分裂症就是人格分裂”

不对。疾病名称中的“分裂”是历史译名，不表示一个人有多个身份。解离性身份障碍与精神分裂症是不同诊断。大众媒体把二者混为一谈，会加深污名。

误区二：“患者都是暴力或危险的”

不能根据诊断标签推断一个人危险。暴力风险受多种因素影响，个体评估应看具体行为、当前危机、既往情况、物质使用和环境等，而不是只看诊断。精神障碍患者也可能遭受暴力、歧视和社会排斥。遇到具体安全风险，应按实际情况求助；不要把刻板印象当作风险评估。

误区三：“这是鬼神附身或单纯想不开”

精神分裂症属于需要专业评估和照护的精神障碍，其病因涉及多因素，尚未完全阐明。宗教或文化支持可在尊重本人选择且不妨碍安全和医疗的前提下提供安慰，但不应以羞辱、强迫、伤害或延误必要医疗的方式替代专业照护。

误区四：“患者没有自知力，不能参与决定”

患者参与决策的能力因人、因时、因具体事项而异。诊断本身不等于失去判断能力或民事行为能力。专业人员应尽可能提供可理解的信息、支持决策并尊重个人意愿；具体法律能力问题须依当地法律程序评估。

误区五：“确诊就等于终身不能工作或独立生活”

不对。症状、功能和康复轨迹因人而异。部分人可在治疗和适当支持下学习、工作、维持关系和独立生活；另一些人需要长期或更多支持。诊断不能单独决定一个人的能力和目标。

误区六：“心理咨询可以单独治愈急性发作”

心理社会干预可与医疗治疗结合，帮助应对症状、压力和功能恢复；急性或严重症状仍需专业评估。不能因使用某种“治愈”宣传而停药、停诊或拒绝急救。

更尊重的表达

尽量使用“精神分裂症患者”或“患有精神分裂症的人”，并尊重本人偏好的称呼；避免“疯子”“危险分子”“没救了”等标签。谈论新闻事件时，不要在缺乏可靠证据时把犯罪行为归因于精神疾病。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services

2. 家属照护难点

照护精神分裂症患者可能带来情绪、时间、经济和关系压力。家属需要支持，但不应被要求独自承担治疗责任；患者也不应因疾病成为家人的“负担”标签。

常见照护挑战

- 难以理解幻觉、妄想或社交退缩等体验；
- 担心复发、安全、服药或身体副作用；
- 反复陪诊、协调服务、照顾日常生活带来的疲惫；
- 家庭成员对诊断和治疗意见不同；
- 面对歧视、经济困难或隐私问题；
- 照护者忽略自身睡眠、身体和情绪需要。

沟通建议

- 选择相对平静的时间交谈，先听当事人最关心什么。
- 用具体观察代替批评，例如“你最近几晚都没怎么睡，我担心你很累”，避免“你又不正常了”。
- 承认对方的感受是真实的痛苦，不需要争辩或认同无法核实的解释。
- 询问是否愿意一起联系医生、安排复诊或讨论副作用。
- 一次讨论一个问题，给对方思考和回应的时间。
- 在本人同意的范围内与治疗团队协作，尊重隐私和自主选择。

如何避免对立升级

若情绪紧张，降低音量、保持空间、减少围观和刺激，暂缓争论。避免威胁、羞辱、强行搜身或自行停药/加药。若存在迫切的人身危险，优先保障现场安全并联系当地急救或紧急服务；不要要求家属独自控制危机。

支持照护者

家属可以向专业人员了解疾病、治疗和复发计划，也可寻求家庭干预、照护者支持、同伴组织或社会服务。安排轮替照护、休息和个人就医并非自私，而是长期照护的重要部分。分享患者信息前应考虑本人同意和隐私。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management

3. 法律与权益

> 本页提供一般信息，不构成法律意见。法律、行政流程和地方服务可能调整；办理具体事项时，应查询现行法规、当地主管部门或合格法律服务。

3.1 尊严、自主与平等

精神障碍诊断不应自动等同于丧失民事行为能力、工作能力或参与医疗决定的权利。个人是否需要监护、如何提供支持，应依具体法律标准和正式程序判断，不能仅凭诊断名称由家属或单位自行认定。

涉及治疗或住院的决定，应了解当事人的知情参与、本人意愿、医疗评估及适用的法律程序。紧急处置的条件和程序较为具体，应由医疗机构依法办理；有争议时可咨询法律专业人士。

3.2 监护与民事行为能力

《中华人民共和国民法典》规定了成年人无民事行为能力、限制民事行为能力及监护等制度，判断关注的是个人辨认和处理相关事务的能力及法定程序，而不是简单根据精神科诊断作结论。不同事务可能需要不同程度的支持；应查阅现行法律并咨询法律服务。

3.3 残疾人证、医保与社会服务

残疾人证认定、医保报销、医疗救助和社区康复服务都有相应资格条件、评估和地方流程。精神分裂症诊断不必然自动获得某项证件或福利；待遇也可能随地区、保险类型和政策变化。可向当地残联、医保部门、卫生健康部门或社会服务窗口核实最新材料与办理步骤。

3.4 就业、教育与合理支持

就业和教育权益受多项法律政策保护，具体保障、合理便利和争议处理方式需结合适用法规、行业及地方规定。诊断信息属于个人健康隐私，不应被随意传播。本人可在权衡隐私与实际支持后，决定是否向学校、雇主或可信任者披露；不确定时，可先咨询专业法律或劳动服务。

3.5 隐私和个人信息

健康和医疗信息属于敏感个人信息范畴，收集、使用、保存和披露应遵守个人信息保护相关法律要求。家属、单位或科普作者不应未经授权公开患者病历、身份、照片或可识别经历。研究和案例分享应采用

适当授权、去标识化及伦理要求。

3.6 查询与求助渠道

- 国家法律法规数据库：全国人大国家法律法规数据库
- 具体政策：当地卫生健康部门、医保部门、残联、人社部门及正规法律援助机构。
- 紧急医疗或人身安全风险：联系当地急救/急诊服务。

办理前请核对政策发布日期、适用地区、所需材料及复议/申诉渠道；必要时保存正式书面答复和办理记录。

参考法律

- 《中华人民共和国精神卫生法》（以国家法律法规数据库现行文本为准）
- 《中华人民共和国民法典》（以国家法律法规数据库现行文本为准）
- 《中华人民共和国个人信息保护法》（以国家法律法规数据库现行文本为准）
- 《中华人民共和国残疾人保障法》及当地配套规定（以现行官方文本为准）

4. 大众科普方向：减少误解与污名

精神分裂症科普不应只介绍症状，也应呈现患者的生活、权利、治疗选择和康复可能性。传播方式会影响公众是否愿意理解、求助与支持。

内容原则

1. 使用准确、非贬损的称呼；解释“精神分裂症不等于人格分裂”。
2. 不把患者描写成同质群体；症状、经历和康复结果存在个体差异。
3. 讲清楚风险因素是群体关联，不把病因归咎于家庭、性格或单一事件。
4. 避免把犯罪或暴力新闻未经证实地归因于精神疾病。
5. 说明科普不能代替诊断、治疗和危机干预。
6. 提供可核实的来源、发布日期和求助渠道；对争议内容明确标注不确定性。

报道与案例分享

报道患者故事前，应取得知情同意，说明传播范围和可能影响；避免披露可识别的病历、照片和家庭信息。讲述康复经历时，应明确这是个人经验，不代表所有患者，也不宣传“保证治愈”的疗法。

涉及自伤、自杀或危机内容时，应采用负责任、非细节化的表达，突出求助和支持信息，避免描述可能造成模仿风险的具体方法。

面向不同受众

- **公众**：解释常见误区、如何尊重和支持，而非让公众自行诊断他人。
- **家庭**：提供沟通、安全和照护资源，同时照顾家属自身需求。
- **学校和职场**：强调隐私、反歧视、合理支持和个体差异。
- **媒体和内容创作者**：核实医学信息，避免戏剧化标签和未经证实的因果推断。

评估科普质量

发布前检查：来源是否权威且仍有效；事实是否区分证据与推测；是否包含刻板印象；隐私是否得到保护；读者是否知道何时、如何寻求专业帮助。

参考来源

- 世界卫生组织：Schizophrenia（精神分裂症）事实清单
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services
- 世界卫生组织：Suicide prevention: resources for media professionals

1. 权威来源标注

整理精神健康资料时，优先使用原始分类、临床指南、系统综述和同行评审研究，并记录版本和访问日期。科普网页适合帮助理解，不应代替诊断手册或临床指南。

推荐资料来源

国际分类与公共卫生资料

- **世界卫生组织（WHO）**：ICD-11 浏览器、ICD-11 临床描述与诊断要求、精神分裂症事实清单、mhGAP 指南及社区精神卫生服务指导。
- **美国精神医学学会（APA）**：DSM-5/DSM-5-TR 及相关临床资料。DSM 原文受版权保护，引用应遵守授权和引用规则。
- **美国国立精神卫生研究所（NIMH）**：面向公众的疾病和研究介绍，可用于入门，关键诊断和治疗信息仍应回到指南。

临床指南

- **NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）**：精神病与精神分裂症评估、治疗和照护指南。指南有适用地区和更新日期，不能自动视为中国大陆政策。
- **WHO mhGAP**：精神、神经和物质使用相关问题的循证指南，适用于其制定的服务背景。
- 中国大陆指南和共识：优先核对中华医学会、中国医师协会或相关专业学会、正式出版物及主管部门发布的版本和年份。引用前确认是否为最新版、适用人群和推荐等级。

记录文献的基本字段

每条资料建议记录：作者/机构、标题、出版物或网站、年份与版本、卷期页码或 DOI、网址、访问日期、资料类型、适用人群和主要局限。网页应优先链接原始发布页，而非转载或搜索结果摘要。

引用与版权

用自己的话概述结论并准确引用来源；直接引语应保持必要、注明页码或段落并遵守版权许可。DSM、指南全文和论文可能受版权保护，不要复制整章或大段原文。网络文章若无作者、日期、来源或利益冲突说明，应谨慎使用。

入口链接

- WHO ICD-11：ICD-11 浏览器
- WHO：ICD-11 临床描述与诊断要求
- WHO：mhGAP guideline
- NICE：Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management
- APA：DSM
- NIMH：Mental health information

来源标注示例

> 世界卫生组织. *Schizophrenia*（事实清单）. 网页资料，访问日期：YYYY-MM-DD. URL：……

> 作者. 文章标题. 期刊. 年;卷(期):页码. DOI：……

2. 区分证据等级

不同问题需要不同研究设计：治疗效果、病因、诊断准确性和个人经历不能用同一种证据标准评判。证据等级也不是给结论贴“绝对正确”标签；应同时看研究质量、结果一致性、适用人群和潜在偏倚。

常见证据类型

- **临床指南**：由专业机构基于证据评估和专家程序形成建议。需检查制定方法、证据检索日期、利益冲突、更新情况和适用地区。
- **系统综述/荟萃分析**：综合多项研究，能提高对整体证据的认识；结论仍受纳入研究质量、异质性和发表偏倚影响。
- **随机对照试验**：常用于比较干预效果，但样本、随访时长和入组条件可能限制对现实患者的推广。
- **队列、病例对照和横断面研究**：可研究风险因素和关联，混杂因素和反向因果使其通常不能单独证明因果。
- **基础或动物研究**：用于探索机制、形成假说，不能直接等同于在人类患者中已证实或可用于临床。
- **个案、专家意见和个人经验**：可提供线索或具体体验，但不能单独代表普遍疗效或风险。

快速评估一项结论

1. 研究问的是什么问题，设计是否适合该问题？
2. 样本量、代表性、对照和随访是否充分？
3. 是否有独立重复研究，结果是否一致？
4. 结果是相关、预测还是因果；效果有多大，是否有不确定区间？
5. 结论适用于什么年龄、地区、诊断版本和医疗环境？
6. 是否报告局限、资助来源和利益冲突？

建议使用的标签

- **指南推荐**：注明指南机构、版本、年份和推荐适用范围；不要写成“对所有人必然有效”。
- **较一致的研究证据**：说明多项研究总体支持，但具体机制或个人效果仍可能不同。
- **初步研究/前沿发现**：标注样本和重复验证限制。
- **研究假说**：明确尚未证实，不用于个体诊断和常规治疗决策。
- **个人经验**：明确是个人叙述，不能代表全部患者。

对病因、基因、脑影像和新疗法等尚未确立内容，建议直接注明：**“尚在研究，未用于常规临床”**，除非已有可靠指南支持其临床用途。

当前研究进展的阅读方向

以下是研究领域的概览，不代表这些方向已经形成可用于个人诊断的检测或常规治疗：

- **遗传学与突触生物学：**大型全基因组研究发现大量与风险相关的位点，并进一步研究相关基因和突触过程；这些是群体关联，不能用于预测某个人是否会发病。
- **多层级脑机制：**研究尝试整合遗传、神经递质、脑网络、发育和环境信息，替代单一病因解释；不同结果仍需重复验证。
- **认知、阴性症状与功能康复：**持续研究如何更好测量这些长期影响，以及心理社会和康复服务如何改善患者重视的生活结果。
- **个体化治疗与生物标志物：**研究在探索哪些特征可能帮助预测治疗反应或不良反应；在充分验证前，不能将候选指标写成常规临床检测。
- **数字健康工具：**可穿戴设备或手机数据等方向正在探索症状和功能监测的可能性，同时需评估准确性、隐私、偏差和临床价值。

截至本资料整理时，不能据此声称已有单一脑扫描、基因或血液检测可以确诊精神分裂症，或能可靠预测个体病程。新增进展应查阅原始研究、系统综述和最新版指南，并标注发布日期。

参考来源

- 世界卫生组织：mhGAP guideline
- NICE：Developing NICE guidelines: the manual
- Cochrane：About Cochrane Reviews
- Trubetskoy V, et al. **Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia.** *Nature*. 2022;604:502–508. doi:10.1038/s41586-022-04434-5

3. 延伸阅读与求助资源

> 服务范围、热线接通情况和资格可能因地区而异。优先使用所在地卫生健康部门、正规医疗机构或专业组织公布的最新联系方式。

科学与临床资料

- **WHO 精神分裂症事实清单**：了解基本症状、疾病负担和公共卫生信息。
- **WHO ICD-11**：查阅正式分类和临床描述；分类文本不是自诊工具。
- **WHO mhGAP**：了解精神健康服务的循证框架。
- **NICE 精神病与精神分裂症指南**：查看评估、治疗和支持建议；注意这是英国指南，具体实施与中国大陆医疗政策不同。
- **APA DSM 信息**：了解 DSM 分类系统；手册原文需遵守版权规定。

寻求评估和持续照护

可联系正规医院精神科、精神卫生中心或当地卫生健康部门公布的心理/精神卫生服务。首次就诊可询问预约方式、费用、隐私保护、可用语言、复诊安排和急诊流程。

心理援助热线和社区服务由各地提供，号码、开放时间和服务范围可能变化。请从当地卫生健康部门、正规医疗机构或政府官方平台查询并核实，不依赖未经确认的社交媒体号码。

紧急情况

若本人或他人存在迫切自伤/伤人危险、意识异常、严重受伤或无法保证基本安全，应联系当地急救/急诊服务。在中国大陆，医疗急救可拨打 **120**；现场存在现实人身安全威胁时可联系 **110**。在其他国家或地区请使用当地紧急号码。尽量让可信任的人陪伴并避免单独处理高风险危机。

患者与家属支持

可向医院社工、社区精神卫生服务、残联或当地社会服务部门询问康复、就业、住房和福利资源；资格和流程以当地正式规定为准。患者互助或家属支持团体可能提供经验支持，但不能代替专业诊疗，加入前应了解隐私和信息使用方式。

资料核验

记录资源的发布机构、服务地区、开放时间、适用对象和核验日期。若联系方式无法从官方渠道确认，不要在资料库中作为确定可用的求助资源发布。

参考入口

- 世界卫生组织：Schizophrenia
- 世界卫生组织：Mental health
- 国家法律法规数据库（查询患者权益相关法规）：flk.npc.gov.cn

4. 资料库备注栏

本资料库用于知识整理和科普，不构成诊断、用药或法律意见，不能替代精神科就诊、急诊评估或当地正式政策解释。内容可能过时，使用前应核对原始来源和发布日期。

资料条目记录模板

每项重要结论可按以下格式记录：

- **主题/结论：**
- **资料类型：**指南 / 系统综述 / 临床试验 / 观察研究 / 基础研究 / 个人经验
- **来源与版本：**
- **发布日期或研究年份：**
- **访问日期：**
- **研究对象与适用范围：**
- **主要结果：**
- **证据局限与不确定性：**
- **利益冲突或资助信息：**
- **是否适用于常规临床：**是 / 否 / 尚不确定
- **下次复核日期：**

内容维护原则

1. 关键医学结论附可核实的原始来源；网页资料保留访问日期。
2. ICD、DSM 和临床指南注明版本，避免把旧版内容当作现行标准。
3. 将指南建议、研究关联、理论假说和个人经验分开表述。
4. 对未定论结果明确注明：**“尚在研究，未用于常规临床”**。
5. 不公布患者可识别的病史、照片、联系方式或未经授权的经历。
6. 发现错误或新指南时，记录修改日期和修改原因，避免静默替换重要结论。
7. 涉及法律、医保、残疾评定和求助热线的信息，应标明适用地区并定期向官方渠道核验。

免责声明

如果本人或家人出现持续或明显加重的精神健康症状，请联系正规精神卫生服务进行评估。出现迫切安全风险、严重意识改变或无法维持基本安全时，应联系当地急救/急诊服务。

共病专题

整理精神分裂症常见共病：抑郁、焦虑、物质依赖、代谢综合征（药物带来高血脂高血糖）。

患者康复视角

收录康复者自述，并注明是个人体验，不能代表全部患者。

照护手册

整理家属实操沟通、危机应急清单。